

INDICADO POR: Dr. Macneira
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JEFFERSON ANDRADE FARIA SILVA

IDADE: 51 PESO: 108 ALTURA: 180 PROFISSÃO: Contador (Faz MBI)
SINTOMAS: Cansaço diurno / Sonolência / (Sábado)

QUEIXAS: Falta de ar

MEDICAMENTOS: Arsenicum Album CH500 / Anti no minu tact + Blatta
orientalis + Sulphur + Histaminum DH

MÉDICO:

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3X condicionamento físico

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (19h)

HORA QUE DORME: 22 - 22:30 HORA QUE ACORDA: 4:40

COCHILHO ☒ S ☒ N FS. DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim BANHEIRO/NOITE: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ↑↑ CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: — MALLAMPATI: IV IAH: 61,9 SPO2: 74% / med. 91%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Nefrologo (3 sem) → P=113 início do Hb.

Hernia umbilical incarcerada (10cm intestino) IA = 11,6 / ev
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA IH = 50,3 / ev

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

04/08/25 Avaliação

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: JEFFERSON ANDRADE FARIA SILVA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 10-07-2025

Idade: 51 anos

Peso: 112 kg

Altura: 1,80 m

Médico Solicitante: DR. ALVARO MACHUCA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 10/07/2025 22:22 e finalizado às 11/07/2025 05:41.

A latência para início do sono foi de 8,5 min e a latência para o sono REM de 10,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 414,0 min, com eficiência do sono de 94,2 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,8 % de estágio N1, 22,5 % de estágio N2, 17,4 % de estágio N3 e 57,4 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 16,9 min. Ocorreram 8 despertares, sendo o índice de 1,1 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 427, sendo 80 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 347 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 61,9 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 80,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 36,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 61,9 (nº/h), sendo 11,6 apneia/h e 50,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 91% e a mínima de 74%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 62,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 86,1 (nº/h) e em NREM foi de 39,4 (nº/h). Permaneceu 16,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (61,9 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (74%);
3. Latência para o início do sono (8,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (10,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (94,2 %) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares 1,1 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (2,8 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (22,5 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (17,4 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (57,4 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

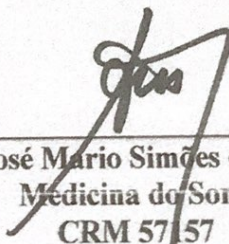
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157